

SKILLS – BMED 2 (ECOS)

→ Examen visuel :

« Bonjour Mr./Mme X, je m'appelle YY, je suis en deuxième année de médecine. Le Docteur Rochat a dû s'absenter et il m'a demandé de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Je souhaiterais contrôler votre acuité visuelle. L'acuité visuelle mesure votre degré de précision à percevoir et à distinguer une cible. Je vais donc chercher la distance maximale pour laquelle vous percevez deux objets distincts.
- J'examinerai un œil après l'autre, est-ce que vous êtes d'accord Mr/Mme X ?
- Pouvez-vous cacher un œil et lire la première phrase ?

Placer le petit livret de lecture dans les mains du patient à 40cm.

Faire la même chose avec l'autre œil.

Mettre en place l'optotype, placer le patient à 6mètres.

- Commençons par l'œil droit. Pour cela, pouvez-vous cacher votre œil gauche s'il vous plaît ?
- Pouvez-vous lire les lettres de cette ligne à voix haute ou m'indiquer le sens des lettres sur cette ligne ?

Faire la même chose pour l'œil gauche.

(Ps : l'examen se réalise avec des lunettes pour ceux qui en portent)

- Nous allons maintenant procéder à l'évaluation de vos champs visuels.

Demander au patient d'enlever ses lunettes s'il en porte.

Tout d'abord effectuer l'examen des champs avec les deux ouverts.

Puis demander au patient de cacher avec sa main un des deux yeux.

Se placer en face du patient à une distance d'un mètre environ. Se mettre à la même hauteur que le patient. Cacher également son œil avec la main et fixer l'œil du patient. Si patient cache son œil droit, il faut cacher son œil gauche (en miroir).

- Pouvez-vous cacher votre œil gauche avec votre main gauche ?
Pouvez-vous fixer mon nez ?

Diviser le champ visuel en 4 cadrans. Placer ses mains, poings fermés dans 2 cadrans. Ouvrir soudainement une des mains, en soulevant des doigts et demander au patient de lui indiquer le nombre de doigts qu'il perçoit en périphérie.

- Pouvez-vous m'indiquer le nombre de doigts que vous voyez, s'il vous plaît ?

Faire des mouvements rapides, mettre les deux mains de chaque côté, de façon à ce que le patient ne sache pas de quel côté on teste son champ de vision.

Si problème => Définir l'extension du scotome.

Si lésion monoculaire => lésion au niveau du nerf optique ou antérieurement.

Si lésion binoculaire => lésion au niveau du chiasma ou dans les voies rétro-chiasmatiques.

- Enfin, on va procéder au test d'Ichihara, c'est un test pour savoir si vous êtes capable de bien distinguer et voir toutes les couleurs.

Montrer 13 planches (sur 38).

- Que voyez-vous ?
- Conclusion ; il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne la performance visuelle. Je vais prendre note de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette à Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journée Mr/Mme X.

➔ Examen Auditif :

« Bonjour Mr./Mme X, je m'appelle YY, je suis en deuxième année de médecine. Le Docteur Rochat a dû s'absenter et il m'a demandé de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Je vais maintenant procéder à un test pour savoir si vous entendez bien. Pour cela je vais vous demander de vous boucher une oreille, je vous dirais un mot et il faudra me le répéter à voix haute, vous avez compris ?

Se placer à environ 30 cm, puis à 60 cm du patient. Prononcer des mots à 2 syllabes dans une oreille puis dans l'autre ; « trente-trois », « lapin », « coquine » ...

- Tout à l'air d'être bon, vous m'entendez correctement.
- Je vais maintenant contrôler que tout va bien au niveau du placement de vos os, notamment au niveau de votre mâchoire.

Palper la mandibule et le condyle de la mandibule, demander au patient de fermer puis d'ouvrir la bouche puis palper la mastoïde et demander au patient s'il ressent une douleur.

- Je souhaiterais contrôler l'état de votre appareil auditif. Pour cela je vais utiliser cet otoscope, est-ce que cela vous va ? Avez-vous déjà eu ce genre d'examen ?
- Est-ce que vous pouvez pencher votre tête vers la gauche ?

Soulever le pavillon de l'oreille, tenir l'otoscope comme un crayon avec la main droite, le manche vers le haut, verticalement. Introduire lentement l'otoscope et observer. Poser sa main sur la joue du patient. Si tympan sain : on observe le triangle lumineux dans la partie postéro-inférieure.

Se munir du bon diapason (le petit). Effectuer le test de Weber en premier.

- Nous allons maintenant effectuer plusieurs tests. Je vais placer ce diapason sur votre tête, est-ce que vous êtes d'accord ?
- Je vais faire vibrer ce diapason qui va donc émettre des vibrations que vous allez percevoir. Lorsqu'il sera dessus, il faudrait que vous m'indiquiez si vous entendez, sentez le diapason des deux côtés ou bien d'un seul côté. Dans ce dernier cas, je vous demanderai de me préciser quel est ce côté.

Faire vibrer le diapason avec la main. Placer le manche fermement sur le vertex ou sur le front. Demander au patient s'il entend le stimulus d'un seul côté ou bien des deux côtés.

Si patient sain : il entend le stimulus des deux côtés.

Si patient atteint :

- *Si c'est une hypoacousie de transmission, le patient entend le bruit du côté de l'oreille atteinte (penser que lorsqu'on se bouche les oreilles avec des boules quies, on entend le son du côté bouché)*
- *Si c'est une hypoacousie de perception, le patient entend du côté opposé à l'oreille atteinte*
- Je vais maintenant placer, dans un premier temps, le diapason en arrière de votre oreille puis, dans un deuxième temps, je vais le rapprocher de votre oreille.
- Le diapason va vibrer et dans un premier temps, vous allez sentir ces vibrations. Lorsque vous ne sentez plus ces vibrations, il faudra me le signaler. A ce moment-là, je placerai le diapason à côté de votre oreille et il faudra m'indiquer si vous entendez ces vibrations.
- Est-ce que vous avez bien compris ? Par précaution, je répète : n'oubliez pas de me faire signe lorsque vous n'entendez plus le diapason vibrer derrière l'oreille.

Faire vibrer le diapason avec la main. Placer le diapason sur la mastoïde. Lorsque le patient n'entend plus rien, déplacer rapidement le

diapason en avant du conduit auditif externe. Effectuez le test sur l'autre oreille.

Le test de Rin   permet de confirmer une surdit   de transmission. Il est positif lorsque Conduction A  rienne > Conduction osseuse et n  gatif lorsque CA < CO.

- Conclusion ; il me semble que nous en avons termin   pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne le contr  le de l'audition. Je vais prendre note de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose    me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette    Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journ  e Mr/Mme X.

→ Examen vasculaire :

PALPATION DE LA FREQUENCE CARDIAQUE ET MESURE DE LA FREQUENCE CARDIAQUE

« Bonjour Mr./Mme X, je YY, je suis en deuxi  me ann  e de m  decine. Le Docteur Rochat a d   s'absenter et il m'a demand   de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Aujourd'hui on va examiner si votre circulation fonctionne bien dans tout le corps, donc je vais dans un premier temps aller chercher les pouls dans les diff  rentes parties du c  ur et dans un second temps, je mesurerai votre fr  quence cardiaque. Percevoir le pouls, c'est-  -dire le flux sanguin puls   par le c  ur (mimer), par palpation de la peau permet de s'assurer de la bonne vascularisation du corps. Est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains. Se chauffer les mains. Inspecter les mains du patients, ses l  vres, sa langue, sa peau (recherche d'une p  leur (localis  e ; art  riopathie oblit  rante ou g  n  ralis  e ; an  mie - ou cyanose). Bien observer les jambes et voir s'il n'y a pas de probl  me d'  d  mes. Regarder les veines jugulaires externes.

- Je ne vois pas de probl  me particulier au niveau de la peau. Est-ce qu'il vous arrive de remarquer des changements de couleur au niveau des extr  mit  s ou des l  vres lorsqu'il fait froid ?
- Je vais maintenant proc  der    l'inspection des pouls.

Comparer les pouls des deux c  t  s. Utiliser d'autres doigts que le pouce. Cotation des pouls art  riels : bondissant, vif (normal), diminu  , absent, impossible    palper.

Pouls carotidien (pouls central) : Placer deux doigts dans le creux du SCM, au niveau de la pomme d'Adam. Il ne faut pas les chercher les deux côtés en même temps. Ne pas appuyer sur le glomus carotidien et ne pas masser (risque de tomber dans les pommes).

Pouls huméral/brachial ; médialement au tendon du biceps.

Pouls radial ; latéral. Pouls cubital.

Pouls fémoral. Porter des gants. Effectuer l'auscultation de l'artère fémorale à la recherche d'un souffle qui n'existe pas chez le sujet sain.

Pouls poplité : empoigner le genou.

Pouls tibial postérieur ; au niveau des malléoles internes.

Pouls pédieux : entre la 1^{ère} et le 2^{ème} métatarse. Parfois absent. Placer sa main au-dessus du pied pour le chercher.

- Tout me semble bon. Vos pouls ont l'air parfaitement normaux. Je vais maintenant mesurer votre fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements du cœur effectués par minute.

Mesurer la FC de préférence sur le pouls radial. Si la FC est régulière, compter le nombre de pulsation sur 15 secondes et multiplier le chiffre par 4. Si la FC est irrégulière, compter le nombre de pulsation en 60 secondes.

FC normal : entre 60-100 battements/min.

- Conclusion ; il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne le contrôle de votre circulation sanguine. Je vais prendre note de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette à Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journée Mr/Mme X.

MESURE DE LA TENSION ARTERIELLE ET DE LA FREQUENCE CARDIAQUE

« Bonjour Mr./Mme X, je m'appelle YY, je suis en deuxième année de médecine. Le Docteur Rochat a dû s'absenter et il m'a demandé de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Aujourd'hui, je vais m'assurer que tout fonctionne au niveau de votre circulation sanguine. Pour cela, je vais mesurer votre tension artérielle. La tension artérielle correspond à la pression du sang qui circule dans les artères. C'est en fait la force qui est exercée par le sang sur la paroi des artères. Elle permet de diagnostiquer/d'identifier des maladies du cœur ou des vaisseaux.

J'utiliserais ce brassard. Est-ce que cela vous va ?

Se laver les mains. Se chauffer les mains. Inspecter les mains du patients, ses lèvres, sa langue, sa peau (recherche d'une pâleur (localisée ; artériopathie oblitérante ou généralisée ; anémie - ou cyanose). Bien observer les jambes et voir s'il n'y a pas de problème d'œdèmes. Regarder les veines jugulaires externes.

- *Je vais maintenant mesurer votre fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements du cœur effectués par minute.*

Mesurer la FC de préférence sur le pouls radial. Si la FC est régulière, compter le nombre de pulsation sur 15 secondes et multiplier le chiffre par 4. Si la FC est irrégulière, compter le nombre de pulsation en 60 secondes.

FC normal : entre 60-100 battements/min.

- *Je ne vois pas de problème particulier au niveau de la peau. Est-ce qu'il vous arrive de remarquer des changements de couleur au niveau des extrémités ou des lèvres lorsqu'il fait froid ?*

Se laver les mains. Procéder à la mesure de la tension artérielle.

Vérifier :

- *les fuites d'air ; imposer une pression de plus de 200 mg pendant plus de 5 secondes*
- *la graduation ; doit être de 0 lorsque la valve de dégonflage est ouverte*
- *le dégonflage ; régulier, à 2 mmHg/seconde*
- *la taille du brassard ; adaptée à la circonférence du bras, suffisamment grande pour que ses 2/3 recouvre la circonférence du bras et sa largeur les 2/3 de la longueur du bras – Si poche trop étroite ; pression surestimée.*

S'assurer que :

- *le patient et la salle d'examen est calme*
- *le patient est bien assis, que ses bras sont relâchés et libre de vêtement*

Positionner l'avant-bras à 90degrés du bras.

Demander au patient sa pression habituelle.

Palper l'artère brachiale au niveau du pli du coude.

Installer le brassard en s'assurant que le centre de la poche gonflable soit positionné en regard du trajet de l'artère humérale, et que le bord inférieur du brassard reste 2-3 cm au-dessus du pli du coude.

Première pression systolique :

- *Rechercher le pouls radial*

- Gonfler le brassard doucement un peu au-dessus de 100-120mmHg
- Lorsqu'on ne sent pas le pouls, on a une première estimation de la pression systolique

Stéthoscope :

- Réchauffer le métal
- Désinfecter entre chaque patient
- Placer la membrane sur la peau, en-dessous du brassard

Gonfler le brassard au-dessus de l'estimation de la pression systolique + 30mmHg.

Dégonfler à une vitesse de 2mmHg par seconde.

Mesurer la pression systolique.

Mesurer la pression diastolique.

Effectuer au moins d'une minute et moyenner les valeurs des 2 dernières.

- Conclusion ; il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne le contrôle de votre circulation sanguine et de votre tension artérielle. Je vais prendre note de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette à Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journée Mr/Mme X.

AUSCULTATION CARDIAQUE

« Bonjour Mr./Mme X, je m'appelle YY, je suis en deuxième année de médecine. Le Docteur Rochat a dû s'absenter et il m'a demandé de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Aujourd'hui je vais m'assurer que tout fonctionne au niveau de votre cœur et de votre circulation sanguine. Pour cela, je vais d'abord inspecter votre thorax (montrer le thorax), puis je procéderai à une palpation de votre pouls et enfin je vous ausculterai, cela vous va ?

Se laver les mains.

- Pouvez-vous retirez votre T-shirt et vous installer sur le dos ? Est-ce que vous êtes confortable ?

Se placer à la droite du patient. Inspection du thorax ; symétrie vs déformations – Couleur normale ? Cyanose, décoloration – Grains de beauté, cicatrices, pacemaker ? – Bonne qualité respiratoire (régulier) – Pulsations au niveau de la VJE : régulières ? Vérifier qu'il n'y a pas

d'endroits plus chaud ou plus froid que d'autre. Bien regarder les jambes, vérifier l'absence d'œdèmes.

- Je vais maintenant mesurer votre fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements du cœur effectués par minute.

Mesurer la FC de préférence sur le pouls radial. Si la FC est régulière, compter le nombre de pulsation sur 15 secondes et multiplier le chiffre par 4. Si la FC est irrégulière, compter le nombre de pulsation en 60 secondes.

FC normal : entre 60-100 battements/min.

En profiter pour prendre la fréquence pulmonaire. FP normale : 12-20 respirations/min.

- Je vais maintenant palper votre pouls carotidien. Vous me dites si vous ressentez une quelconque gêne.

Si on est à droite, on utilise sa main gauche. Avec le pouce, palper l'artère carotide droite du patient.

Poser sa main également sur l'endroit où se situe le cœur pour rechercher un frémitus. Palper également le début de la trachée.

- Je vais essayer de sentir votre choc de pointe. C'est un petit endroit du côté gauche de votre corps où l'on peut vraiment voir le cœur battre.

Chercher le choc de pointe au niveau du croisement du 5^{ème} espace intercostal et de la ligne médio-claviculaire au niveau de l'apex. Si on ne le voit pas, demander au patient de se mettre en décubitus latéral gauche. Si on ne le voit toujours pas, ce n'est pas grave. Si on le sent plus latéralement ou inférieurement : cardiomégalie.

- Je vais maintenant vous ausculter. Pour cela je vais vous demander de ne pas parler. Comme cela, je pourrais vous examiner au mieux.

Environnement calme. Prendre le pouls radial en même temps. « All patient take morphin » ;

- A ; valve aortique ; utilisation de la membrane
- P : valve pulmonaire ; utilisation de la membrane
- T ; valve tricuspide ; utilisation de la cloche
- M ; valve mitrale ; utilisation de la cloche

Placer le patient en décubitus latéral si on suspecte une sténose ou une insuffisance mitrale. Placer le patient tête en avant si on suspecte un souffle au cœur.

- Conclusion ; il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne le contrôle de votre circulation sanguine et de votre cœur. Je vais prendre note de ce

que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette à Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journée Mr/Mme X.

AUSCULTATION PULMONAIRE

« Bonjour Mr./Mme X, je m'appelle YY, je suis en deuxième année de médecine. Le Docteur Rochat a dû s'absenter et il m'a demandé de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Aujourd'hui, je vais m'assurer que tout fonctionne bien au niveau respiratoire. Donc je vais surtout m'intéresser à vos poumons mais je vais aussi inspecter l'état général, votre thorax (montrer le thorax), puis je procèderai à une palpation de vos ganglions, j'effectuerai également ce que l'on appelle une « percussion » pour m'assurer que je n'entends pas des bruits étranges et enfin je vous ausculterai, est-ce que vous êtes d'accord ?
- Pouvez-vous retirer votre T-shirt et vous installer sur le dos ? Est-ce que vous êtes confortable ?

Se laver les mains.

Inspection –

Signes de détresse respiratoire ;

- Téguments ; cyanose (mains, yeux, muqueuse buccale), transpiration
- Bruits ; sifflement
- Effort ; contraction des muscles respiratoires accessoires, contraction des muscles SCM, rétraction sus-claviculaire ou intercostale

Forme du thorax et mouvements respiratoires ;

- Forme du thorax ; déformations ? Asymétrie D/G ? Cicatrices (demander au patient si opérations)
- Mouvements du thorax ; Expansion thoraco-abdominale inspiratoire, prédominance du mouvement de l'abdomen (le ventre doit se gonfler à l'inspiration), symétrie D/G
- Je vais mesurer votre fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur que vous effectuez en 1 minute.

Prendre la fréquence cardiaque. Ne pas dire au patient que l'on prend aussi la fréquence respiratoire. Compter les mouvements respiratoires effectués en 15 secondes puis multiplier par 4.

- Vous avez une fréquence cardiaque de ex ; 60/min. J'ai également déterminé votre fréquence respiratoire qui est de ex ; 16 cycles/min.
- Maintenant je vais palper vos ganglions. Expliquer ce que c'est si besoin (lieux de travail de votre système immunitaire qui vont grossir s'il y a des infections).

Se laver les mains.

Cervicaux : le long du côté médial du SCM.

Sus-claviculaire ; au-dessus de la clavicule.

Axillaires ; palper les ganglions avec les gants.

Inguinaux : avec les gants.

Palper toute anomalie visible ou zone douloureuse.

- Je vais placer mes mains sur votre thorax, il faudra respirer d'abord normalement puis ensuite prendre une grande inspiration afin que j'évalue au mieux l'amplitude et la symétrie du mouvement, d'accord ?

Mains appliquées symétriquement sur chaque rebord costal. Evaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement lors d'une grande inspiration.

- Je vais faire ce que l'on appelle une percussion pulmonaire. Je vais juste placer ma main sur différentes parties de votre corps et appuyer avec deux doigts sur mon majeur pour vérifier que je n'entends pas de bruits particuliers.

Poser le majeur sur la zone que l'on souhaite percuter. Percuter le majeur avec l'index et le majeur de l'autre main. Faire des mouvements forts et utiliser la pulpe du doigt.

Percuter les deux côtés : LSD, LSG, LM (que à droite), LIG, LID.

Base droite ; transition entre la sonorité du poumon et la matité du foie => ce qui permet de délimiter le foie.

Base gauche ; transition entre la sonorité du poumon et le tympanisme de l'estomac => permet de délimiter le tympanisme de l'estomac.

Percuter latéralement.

- Je vais vous ausculter, pour cela, je vais vous demander de ne pas parler. Comme cela, je pourrais vous examiner au mieux.

Utiliser la membrane du stéthoscope.

- Pouvez-vous respirer avec la bouche ouverte ?

Ausculter de gauche à droite, le thorax et sur les côtes. Symétriquement.

Ausculter également latéralement. Ecouter le bruit laryngo-trachéal ; plus haut et plus fort.

Son de référence : murmure respiratoire (vésiculaire).

- Puis-je vous demander de vous installer en position assise ? Je vais réeffectuer les mêmes manœuvres mais cette fois-ci sur votre dos.

Inspection ;

Forme du thorax ; déformations ? Asymétrie G/D ? Cicatrices ?

Mouvements respiratoires.

Palpation ; Toute anomalie douloureuse.

- Est-ce que vous avez mal quelque part ?

Ampliation thoracique :

- Pouvez-vous expirer profondément ?

Appliquer les mains symétriquement sur les côtes inférieures.

- Pouvez-vous inspirer ?

Laisser les mains se déplacer selon le mouvement respiratoire.

Percussion : Ne pas percuter la scapula ; demander au patient d'effectuer une rotation externe.

Percuter et comparer les deux côtés. Délimiter les bases pulmonaires ; transition entre les sonorités du poumon et la matité des loges lombaires.

Auscultation : Utiliser la membrane du stéthoscope.

Comparer les zones symétriques des poumons. Le murmure respiratoire est entendu.

- Conclusion ; il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne le contrôle de votre circulation sanguine et de votre cœur. Je vais prendre note de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette à Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journée Mr/Mme X.

➔ Examen digestif :

« Bonjour Mr./Mme X, je m'appelle YY, je suis en deuxième année de médecine. Le Docteur Rochat a dû s'absenter et il m'a demandé de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Aujourd'hui je vais m'intéresser surtout à la fonction digestive. Pour cela, je vais procéder à un ensemble d'observations et de

palpations et je vous ausculterai également, est-ce que vous êtes d'accord ?

- Est-ce que vous avez besoin d'aller aux toilettes ? (il est préférable pour cet examen que vous ayez la vessie vide) - Pouvez-vous retirer votre T-Shirt et vous installer sur le dos ?

Est-ce que vous êtes confortable ?

Se laver les mains. Se réchauffer les mains. S'assurer que le patient n'a pas ses mains sur son ventre mais bien sur les côtés, les bras le long du corps. Lui mettre un coussin sous la nuque.

- Est-ce que vous avez mal quelque part ?

Observer le patient, comment il respire, s'il n'a pas mal ; il respire avec le ventre.

Observer le visage du patient (malaise, douleur, respiration).

Observer la peau. Vergetures, veines dilatées, lésions cutanées, péristaltisme. Cicatrices ?

- Avez-vous été opéré quelque part ?

Observer l'ombilic ; est-il bien au milieu ?

Y-a-t-il une voussure ? Couleur ? Hernie ?

Mouvements ; respiratoires, péristaltiques, pulsatiles.

- Je vais maintenant vous ausculter, pour cela je vais vous demander de ne pas parler. Avant que je commence, est-ce que vous ressentez des douleurs à un endroit particulier ?

Ecouter les 4 quadrants ; on peut provoquer des petits bruits et ensuite écouter. On appuie avec le stéthoscope et on écoute.

Ecouter l'aorte avec la cloche.

- Je vais maintenant procéder à ce qu'on appelle une « percussion », cette manœuvre permet d'observer où se trouve les différents organes et de vérifier s'ils sont à la bonne place ainsi que de vérifier qu'il n'y a pas de bruits particuliers.
- Si jamais vous ressentez une quelconque douleur, je vous prie de me l'indiquer.

Se laver les mains, les réchauffer.

Commencer la percussion au niveau des poumons et descendre le long de la ligne médio-claviculaire, jusqu'à entendre le tympanisme de l'abdomen. Déterminer la taille de foie au niveau de la ligne médio-claviculaire.

- Je vais effectuer différentes palpations au niveau de votre ventre. Si jamais vous avez mal quelque part, prévenez moi. Et je vous prie de respirer par la bouche.

Palpation superficielle à une main (permet d'enlever les résistance musculaires). Palpation plus profonde ; superposition des deux mains pour mieux contrôler la force.

Effectuer un certain nombre de détentes (appuyer puis relâcher lentement). Demander au patient s'il a mal.

Palper l'aorte ; avec les deux mains légèrement à gauche de la ligne médiane.

Appuyer profondément et lâcher sans prévenir en regardant le visage du patient.

Effectuer l'examen de McBurney et le signe du Psoas : appuyer sur le point McBurney (crête illiaque/ ombilic).

Vérifier que ce n'est pas une appendicite rétro-caecale :

- *Pouvez-vous fléchir votre cuisse ?*

Appuyer vers le bas. Si le patient n'a pas mal ; pas d'appendicite.

Palper le foie. Avec les deux mains. Demander au patient de prendre une grande inspiration et essayer de sentir le bord du foie. Technique du crochet aussi possible.

Signe de Murphy ; palpation de la vésicule biliaire ; placer ses mains au niveau du rebord costal droit. Si cholécystite ; le patient a mal.

Percuter et délimiter la rate. Palper la rate avec les deux mains. Demander au patient de respirer profondément.

La rate n'est jamais palpable physiologiquement.

- *Pouvez-vous vous asseoir ? Je vais vérifier s'il n'y a pas de problème au niveau des reins. Je vais juste taper légèrement votre dos et si vous ressentez une douleur, je vous prie de me l'indiquer.*

Poing fermé, l'examineur percute les reins au niveau de l'angle costo-vertébral.

- *Pouvez-vous vous réallonger ? Je vais palper vos reins.*

Placer sa main gauche derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^{ème} côte. Placer sa main droite latéralement et parallèlement au muscle droit. Essayer de « capturer » le rein entre les deux mains. Demander au patient de prendre une grande inspiration à nouveau. Pour le rein gauche, la même chose mais avec une main au niveau du quadrant supérieur gauche.

- *Dernière petite vérification, je vais placer ma main au niveau de votre nombril, de votre ventre (et éventuellement au niveau de vos*

cicatrices) et je vais vous demander de relever la tête afin de contracter vos abdominaux.

Placer son doigt au niveau du nombril. Demander au patient de lever la tête. Placer son doigt au niveau de la zone épigastrique et demander au patient de lever la tête. De même pour toute éventuelle cicatrice.

- Conclusion ; il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne le contrôle de votre système digestif et des organes viscéraux. Je vais prendre note de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette à Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journée Mr/Mme X.

→ Examen et cotation articulaire

« Bonjour Mr./Mme X, je m'appelle YY, je suis en deuxième année de médecine. Le Docteur Rochat a dû s'absenter et il m'a demandé de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Aujourd'hui je vais m'intéresser principalement à vos fonctions articulaires et à votre mobilité de manière générale. Je vais surtout m'intéresser à l'articulation de l'épaule et du genou.
Pour cela, je vais utiliser un instrument appelé goniomètre qui est constitué de 2 réglettes qui me permettra de mesurer les différents angles effectués par les mouvements de flexion/d'extension ou autres (montrer ce que sont ces mouvements). En fait, je le place au-dessus d'une articulation, une réglette reste sur l'articulation et l'autre suit le mouvement. Dans certains cas je vous laisserai effectuer les mouvements par vous-même, dans d'autres, c'est moi qui déplacerai vos membres pour réaliser ces mouvements afin d'avoir une idée de jusqu'où vous pouvez aller.
Est-ce que vous avez bien compris ? Est-ce que vous avez des questions ?

Pouvez-vous vous déshabiller svp ? (Ne pas aider le patient à se déshabiller)

Pour l'épaule d'abord

Examiner la présence d'hématomes, de brûlures, évaluer la symétrie (d'éventuelles scolioses...). Parler au patient et lui expliquer ce que l'on fait.

- Je vais à présent palper vos articulations, si vous ressentez quelconques douleurs, n'hésitez pas à me le signaler.

Palper l'articulation acromio-claviculaire, l'articulation gléno-claviculaire, l'articulation sterno-costoclaviculaire.

- Maintenant je vais effectuer une flexion complète avec votre bras, vous pouvez vous laissez faire.

Effectuer une flexion passive, si douleurs ; test de Neer positif.

Effectuer une rotation interne passive, bras fléchis à 90 degrés dans le plan de l'omoplate – si douleurs ; test de Hawkins positif.

- Maintenant nous allons examiner votre mobilité et votre force articulaire.

Se placer de côté, latéralement au patient. La position de repos correspond au bras collé contre le thorax.

- Pouvez-vous réaliser une flexion puis une extension (montrer les mouvements si besoin).

Effectuer ces deux mouvements passivement. (La flexion passive a déjà été réalisée préalablement mais peut être ré effectuée). Mesurer les angles avec le goniomètre – résultat noté par 3 chiffres : Flexion maximale – Position neutre (flexum) – Extension- (140-0-10 - 140-10-0)

Flexion : mm. grand pectoral, coraco-brachial, deltoïde.

Extension : mm. Deltoïde, grand pectoral.

Faire de même avec l'autre bras.

Se placer derrière le patient.

- Pouvez-vous réaliser une abduction (vers le haut) ? (Montrer)

Force du m-supra-épineux et deltoïde.

- Pouvez-vous réaliser une adduction ?

Force ; mm. Grand dorsal, grand pectoral, coraco-brachial, subscapulaire, grand rond, deltoïde.

Mesurer les angles. Réaliser ces mouvements passivement.

Idem avec l'autre bras.

Se placer latéralement.

- Pouvez-vous réaliser une rotation externe, c'est-à-dire placer vos coudes sur vos côtes et mettre vos bras le plus derrière possible.

Réaliser ce mouvement de manière passive. (Force du sous-épineux, petit rond et deltoïde). Une augmentation asymétrique de la rotation externe passive lorsque le coude est au corps évoque aussi une rupture du tendon subsclapulaire.

Idem autre bras.

- Pouvez-vous réaliser une rotation interne ?

L'examineur se place latéralement. Flexion du bras à 90 degrés, collé contre le thorax.

Force : mm.subscapulaire, grand rond, grand dorsal, grand pectoral et deltoïde.

Lift-off: les mains derrière le dos et l'examineur exerce une force opposée.

L'évaluation les mains peut être douloureuse, donc il existe une variante appelée Belly-Press : appuyer fortement sur l'abdomen en gardant le coude en avant ; si le coude n'est pas maintenu en avant => pb.

Tester le mouvement passif : le patient place le plat de sa main dans le dos, l'examineur essaie ensuite de le monter le plus haut possible.

L'examineur mesure la distance entre le pouce du patient et la C7.

Idem avec l'autre bras.

Nb : un résultat physiologique suppose que la distance soit identique pour chaque bras.

Pour l'examen du genou

- Je vais maintenant examiner votre genou. Pouvez-vous vous marcher normalement ?

En position debout statique ; Evaluation qualitative du morphotype en morphologie valgus et varus. L'atrophie musculaire peut également être appréciée.

En marche ; tout signe anormal.

- Pouvez-vous vous installer sur le dos ?

Identifier la présence anormale de chaleur ou d'une tuméfaction, de cicatrices. Déterminer si les jambes sont symétriques.

Evaluation de 2 signes essentiels qui traduisent une lésion réelle et organique du genou ; l'épanchement articulaire et flexum.

La recherche de l'épanchement articulaire se fait en positionnant une main en-dessus et en-dessous de la rotule permettant de chasser le liquide synovial distalement.

La pression réalisée avec l'index sur la rotule recherche le choc rotulien. A la palpation, on peut également relever des bombements provoqués par l'épanchement.

Pour recherche le flexum, l'examineur empaume les 2 talons et relève les 2 jambes : c'est dans cette position que l'on met le mieux en évidence le flexum. En callant les pieds du patient sur soi, on peut tester la réductibilité du flexum.

- Pouvez-vous fléchir votre genou ?

Le patient fléchit sa jambe (il ramène sa malléole vers le côté postérieur proximal de sa cuisse). Mesurer l'angle.

Faire la mesure en passif.

Idem autre membre.

- Pouvez-vous remettre votre jambe allongée simplement ?

Mesurer l'extension. Bien observer le muscle quadriceps.

Prendre la jambe du patient et évaluer la laxité frontale en plaçant la main droite vers l'intérieur et déplacer le tibia médialement (varus) (évaluation des ligaments collatéraux tibiaux) et latéralement (valgus) (évaluation des ligaments collatéraux fibulaires) en stabilisant la cheville avec l'autre main.

Faire la même chose en flexion de 30 degrés. Le genou est normalement plus laxé latéralement que médialement.

Idem avec l'autre jambe.

L'examineur se place au bout de la table d'examen.

Le patient place ses jambes en extension, rotules au zénith.

L'examineur réunit, si possible, les 2 malléoles.

Si les distances entre les deux condyles fémoraux internes et celle entre les deux malléoles sont nulles, le morphotype est normo-axé.

Varus (lucky-luke) ; un espace (en cm) est mesuré entre les 2 condyles.

Valgus (en X) ; un espace est mesuré entre les deux malléoles.

- Conclusion ; il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne le contrôle de votre

mobilité et de vos articulations. Je vais prendre note de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette à Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journée Mr/Mme X.

→ Examen neurologique

« Bonjour Mr./Mme X, je m'appelle YY, je suis en deuxième année de médecine. Le Docteur Rochat a dû s'absenter et il m'a demandé de m'occuper de vous aujourd'hui, est-ce que cela vous convient ?

Se laver les mains.

- Qu'est-ce qui vous amène ?

(Bilan neurologique)

Examen sommaire des fonctions cognitives.

- Si vous le permettez, je vais commencer par vous poser quelques questions simples. Savez-vous quel jour on est ? Le jour de la semaine ? Où vous-êtes ici ? Quel étage ? Votre date de naissance ?
- Je vais maintenant vous présenter une liste de 5 mots, est-ce que vous pouvez lire cette liste à haute voix svp ?
« Bleu, Poire, Lapin, Violon, Tulipe »
Dans cette liste, il y avait un animal, lequel ?
Une couleur ? Un instrument de musique ? Un fruit ? Une fleur ?
Très bien, je vous reprendrais ces questions à la fin de l'examen pour tester votre mémoire.
- Maintenant, nous allons un peu examiner le langage, pouvez-vous fermer les yeux, ouvrir la bouche et lever votre bras droit ?
- Est-ce que vous pouvez répéter le mot « bibliothèque » ?
- Est-ce que vous pouvez répéter la phrase « Il fait beau mais je n'irais pas me promener »
- Comment s'appelle cet objet ? Montrer un bracelet par exemple, puis la blouse, puis le badge.
- Pouvez-vous épeler les jours de la semaine à l'envers ?
- Pouvez-vous répéter les mots que vous avez lu avant ?

Examen des nerfs crâniens.

Nerf olfactif.

Demander au patient de se boucher une narine puis lui tendre une substance à sentir.

Nerf optique.

Voir test examen visuel.

+ réflexes pupillaires ; demander au patient de mettre sa main entre les deux yeux et éclairer un œil puis l'autre en observant si la rétraction pupillaire a lieu et si elle se fait de manière consensuelle (au niveau de l'autre œil également).

Examen des champs visuels : se cacher les mêmes yeux que le patient et lui demander s'il voit la main bouger dans chaque quadrant.

Nerfs oculomoteur (III), trochléaire (IV) et abducens (VI).

Regarder la position des yeux, rechercher une ptose palpébrale.

Demander au patient de regarder vers le haut, le bas, à D et G.

Tester la poursuite oculaire dans les 8 directions en demandant au patient de fixer le doigt, mouvement à droite, à gauche (observer s'il y a un nystagmus), vers le haut, le bas, vers le haut à D, vers le haut à G, vers le bas à G et vers le bas à D.

Nerf trijumeau (V).

Sensibilité de la face et motricité des muscles masticateurs. Casser un bâtonnet ; extrémité pointue, douce pour s'assurer que les modalités de sensibilité sont toujours là.

Ça touche ? Ça pique ?

Réflexe masséter ; mains entre le menton et percussion à ce niveau-là.

Cas pathologique : réflexe exagéré.

Nerf facial (VII).

Motricité des mm. Du visage.

Important de faire la distinction entre le haut et le bas du visage.

Demander au patient de faire différentes grimaces ; « Haussez les sourcils, froncez les sourcils, fermez les yeux fort – Montrez les dents, gonflez les joues, sifflez »

Nerf vestibulo-cochléaire (VIII).

Faire un petit bruit avec la main au niveau des oreilles.

Test de Rinne et Weber.

Surdit  de transition ou de perception ?

Rechercher un nystagmus avec la poursuite du doigt.

Epreuve Almaghi : prendre la t te du patient entre les mains et lui demander de fixer notre nez puis effectuer une rotation rapide de la t te.

Nerfs glosso-pharyngien (IX) et Nerf Vague (X).

Examiner le fond de la gorge et la contraction du voile du palais puis la phonation. Prendre un abaisse langue : dire « aaaahhhh » puis « hahaha » - Etre attentif à la contraction du voile du palais des 2 côtés ; symétrie doit être là et la luette doit être maintenue droite. Abaisse langue on touche la luette pour évaluer la présence du réflexe vomitif.

Pour la phonation, on a déjà entendu le patient parler et on lui fait répéter des sons « aaah, euuuh, iiiii, oooo, uuuuu ».

Pour la déglutition, on place les mains sur la glotte et on demande au patient de déglutir.

Nerf spinal ou accessoire (XI).

On demande de lever les épaules et demander à faire une rotation de la tête d'un côté et de l'autre.

Demander au patient de lever les épaules puis essayer de vaincre la force en appuyant sur celles-ci et demander de tourner la tête et de l'abaisser tout en exerçant une force contraire au niveau de la tête avec la main.

Nerf hypoglosse (XII).

Fonction de protrusion de la langue.

Demander au patient de tirer la langue et de faire des mouvements.

Réflexe cornéen.

Prendre du coton et toucher la cornée sans que le patient ne le sache.

Examen du système moteur.

Inspecter la posture du patient. La symétrie de ces épaules, ses jambes si elles sont en valgus ou varus...

- Pouvez-vous maintenant vous relever ?
- Pouvez-vous maintenant vous accroupir et remonter ?
- On va maintenant tester votre équilibre en effectuant l'épreuve de Romberg, je vous laisse serrer les pieds, tendre les bras devant vous et fermer les yeux.

Laisser le patient dans cette position pendant une quinzaine de secondes.

- On va examiner votre marche, marchez normalement.

Mesurer la vitesse de la marche, le balancement des bras, l'écartement des pieds.

- Maintenant vous pouvez marcher comme un funambule.

- Vous pouvez maintenant marcher sur la pointe des pieds, sur les talons – Pouvez-vous sautiller sur une jambe ? Sur l'autre jambe ?
- Je vais d'abord réaliser une petite inspection et palpation pour voir s'il y a une faiblesse musculaire.

Palper les loges ant du bras, des avant-bras, les loges interosseuses de la main. Palpation du thénar, de l'hypothénar. Palpation et évaluation des muscles de la cuisse et recherche d'une amyotrophie du muscle de la loge antérieure de la jambe (inspection via une flexion passive du genou).

- Je vais maintenant évaluer votre tonus musculaire au niveau de votre tête et au niveau des extrémités.

Prendre en main la nuque et effectuer une flexion passive.

Au niveau de l'épaule on effectue un mouvement passif du coude et du poignet (secouer ces deux articulations).

Pour sensibiliser la méthode ; demander au patient de réaliser un mouvement actif de flexion et d'extension du poignet, du coude et de l'épaule.

Pour le membre inférieur, mobilisation passive répétée au niveau de la hanche, du genou et de la cheville (secouer ces articulations dans tous les sens).

- Je vais maintenant évaluer votre force musculaire au niveau des muscles supérieurs.

Evaluer les mm. Biceps brachial, Deltoïde, triceps brachial, interosseux (innervation C6, C5, C7 et C8 respectivement).

Deltoïde : main du patient sur la poitrine, élévation du coude vers le haut.

On exerce une force pour s'opposer à ce mouvement.

Biceps ; flexion simple du coude contre résistance à D et G.

Triceps ; extension du coude contre résistance.

Interosseux ; écartement maximal des doigts du patient contre résistance.

Test des bras tendus :

- Pouvez-vous tendre vos bras et vos doigts vers le ciel ? Le patient doit garder cette position pendant 15-20 secondes. Pouvez-vous fermer vos yeux ?
- Pouvez-vous effectuer des petits mouvements rapides avec vos doigts ?

- Nous allons en faire de même pour vos muscles inférieurs. Il faudra faire des mouvements de flexion et d'extension contre résistance, c'est-à-dire contre moi qui appuie pour contrer votre mouvement.

Réaliser des mouvements de flexion de la cuisse (du bassin), provoquer une force opposée à ce mouvement.

Pour l'extension de la jambe, demander au patient de pousser son genou vers le lit d'examen – il faut l'empêcher d'effectuer ce mouvement.

Réaliser une extension de la jambe entière en évaluant le quadriceps.

La flexion du genou est évaluée aisément en demandant au patient de mettre le talon en direction de la cuisse.

Extension dorsale du pied contre résistance (le lit d'examen doit bouger).

Examen dorsal de l'extension du gros orteil.

Flexion plantaire des pieds.

Inversion et Eversion des deux côtés du pied.

Manœuvre des jambes fléchies :

Le patient, couché sur le dos, doit maintenir ses jambes fléchies vers le haut pendant une quinzaine de secondes.

Examen de la hanche et épreuve de Lasègne.

Faire des mouvements passifs de la hanche puis extension passive de la jambe entière (on la lève vers le haut).

- Je vais à présent évaluer vos réflexes moteurs lorsque vous êtes en position couchée puis nous ferons de même lorsque vous serez en position assise.

Utiliser un marteau à tête lourde. Le patient doit être décontracté.

Muscle biceps brachial ; Dépression du tendon du muscle examiné soit avec le pouce, soit avec l'index. Percussion vive sur le tendon. Faire des 2 côtés ! Importance de la symétrie. Manœuvre de facilitation peut être demandée si difficulté à obtenir un réflexe suffisant ; patient doit lever sa tête.

Muscle brachio-radial ; percussion de l'apophyse stylo-radiale ; on peut interposer les doigts pour éviter la douleur.

Muscle triceps ; bras mis sur le thorax. Le tendon est percuté des deux côtés.

Reflexe rotulien : la flexion de la jambe facilite la prise de ce réflexe.

Faire de même du côté controlatéral.

Réflexe achilléen ; Faire une rotation externe. Demander une manœuvre de facilitation au patient ; tirer ses doigts vers l'extérieur.

Tester également le réflexe cutané plantaire ; en stimulant avec le pouce ou le manche du marteau depuis la base jusqu'à la base du gros orteil. Réponse physiologique : flexion.

Réponse pathologique ; extension, signe de Babinski.

- Je vais vous demander de vous asseoir. Nous allons refaire la même chose mais au niveau de votre membre supérieur.

Réflexe brachial, brachioradial, triceps brachial.

Rotulien, achilléen (l'examineur doit faire une flexion du pied).

Tester également le réflexe cutané plantaire ; en stimulant avec le pouce depuis la base jusqu'à la base du gros orteil.

Examen de la sensibilité.

Discrimination toucher/piquer.

- Nous allons maintenant nous intéresser à votre sensibilité.
On va tester cette sensibilité à l'aide d'une tige qui comporte une partie pointue pour détecter la douleur et une partie en coton pour ressentir simplement le toucher fin.

Montrer ce que doit être le toucher et le piqué, le patient doit avoir les yeux ouverts.

- Est-ce que vous pouvez fermer les yeux et dire si vous ressentez une sensation de toucher ou si cela pique ?

Faire le test au niveau de l'abdomen et au niveau des membres inférieur et supérieur.

Jeter le bâtonnet à la fin de l'examen.

Examen du sens vibratoire ou pallesthésie.

- Nous allons maintenant tester la sensibilité vibratoire. Je vais donc appliquer cette partie du diapason (pallesthésie) sur différentes parties de votre corps et vous devrez me dire si vous sentez la vibration et si oui, à quel moment cette vibration s'arrête. Pour cela, je vais vous demander de fermer vos yeux.
Est-ce que vous sentez la vibration ? Vous me dites lorsque cela s'arrête ?

Appliquer le diapason sur l'os du poignet. Faire la même chose au niveau des malléoles.

Examen du sens postural ou proprioception.

- Nous allons maintenant tester la sensibilité de la position. Je vais donc prendre votre doigt et je vais le faire descendre et monter. Avec les yeux fermés, vous devez me dire si par rapport à la

position d'avant, le doigt est monté ou descendu. Vous avez bien compris ?

Effectuer le test. Des deux côtés.

- On va tester le sens de la même position mais avec vos orteils.

Répéter le test avec le gros orteil.

Examen de coordination.

Epreuve doigt-nez.

- On va tester votre coordination avec une épreuve appelée « doigt-nez », pouvez-vous tendre votre bras droit et toucher votre nez.

Pouvez-vous faire la même chose de l'autre côté.

Bien observer que le mouvement se fait sans problème.

- Pouvez-vous le faire les yeux fermés ?

Epreuve du rebond.

- On va continuer l'examen de votre coordination avec une épreuve qui s'appelle l'épreuve du rebond. Pour cela vous devez plier le bras, vous allez tirer vers vous et moi je vais lâcher brusquement et vous essayer de freiner le mouvement.

Bien mettre la main vers le patient pour protéger le patient si son mouvement est trop fort. Un patient sain est capable de freiner le mouvement.

Epreuve des marionnettes.

- On va faire un autre test de coordination qui s'appelle « le test des marionnettes ». Pouvez-vous lever la main et faire des mouvements amples avec les poignets le plus rapidement possible ? Garder le coude stable.

Epreuve talon-genou.

- On va maintenant tester votre coordination du membre inférieur. Pouvez-vous lever le pied très haut et avec le talon glisser le talon sur la crête du tibia, sur la jambe ?

Le mouvement doit être rectiligne, sans zigzag, sans crochet.

- Pouvez-vous répéter ce mouvement les yeux fermés ?
- Conclusion ; il me semble que nous en avons terminé pour aujourd'hui ; du moins en ce qui concerne le bilan neurologique. Je

vais prendre note de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou quelque chose que vous aimeriez que je transmette à Dr.Rochat ? ... Je vous remercie, au revoir, bonne journée Mr/Mme X. »